

Documento generado por MARU OS a partir de la base de conocimiento offline.
Fuentes etiquetadas honestamente (resúmenes MARU basados en normas/guias).
No sustituye asesoría médica, legal o de emergencia profesional.

1. Dengue: diagnóstico y manejo clínico (MINSA)

Fuente: NTS N° 125-MINSA/2016/CDC-DGIESP - Norma Técnica de Salud para la vigilancia y atención de casos de dengue

Agentes: aya, tupac

El dengue es una arbovirosis transmitida por el zancudo *Aedes aegypti*. Cuadro típico: fiebre alta (2-7 días), cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea. Signos de alarma (requieren atención inmediata): dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, acumulación de líquidos, hepatomegalia >2 cm, aumento del hematocrito con caída rápida de plaquetas. **REGLA CRÍTICA DE SEGURIDAD:** en caso de dengue probable o confirmado está PROHIBIDO usar AINEs (ibuprofeno, naproxeno), aspirina (ácido acetilsalicílico) o corticoides, porque aumentan el riesgo de sangrado y gastritis hemorrágica. El único antipirético/analgésico indicado es PARACETAMOL (adultos: 500 mg - 1 g cada 6 horas, max. 4 g/día). No se usan antibióticos ni antivirales específicos. Manejo grupo A (sin signos de alarma): hidratación oral abundante, paracetamol, reposo, control diario y búsqueda activa de signos de alarma. Grupo B (con signos de alarma o comorbilidad): observación/hospitalización con hidratación endovenosa. Grupo C (dengue grave): emergencia - choque, sangrado grave o daño de órganos; manejo en UCI. Prevención: eliminar criaderos (recipientes con agua), uso de repelente y ropa de manga larga. Ante sospecha, acudir al establecimiento de salud más cercano; no automedicarse.

2. RCP básico en adultos (reanimación cardiopulmonar)

Fuente: Guías AHA 2020 de RCP básico (soporte vital básico), adoptadas por MINSA/SAMU - Emergencias: SAMU 106, Bomberos

Agentes: aya, tupac

Cadena de supervivencia ante un adulto que no responde y no respira (o solo jadea/boquea):

- 1) Verificar seguridad de la escena.
- 2) Comprobar respuesta (hablarle, estimular hombros).
- 3) LLAMAR AL SAMU 106 (o Bomberos 116) y pedir un DEA (desfibrilador externo automático) si hay alguno cerca.
- 4) Iniciar compresiones torácicas de inmediato: centro del pecho (mitad inferior del esternón), con el talón de una mano y la otra encima, brazos rectos; profundidad de 5-6 cm; frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto; permitir la reexpansión completa del tórax entre compresiones y minimizar interrupciones.
- 5) Si está entrenado: 30 compresiones y 2 ventilaciones (30:2). Si no está entrenado o no puede ventilar, hacer RCP solo con las manos (compresiones continuas) - también salva vidas.
- 6) En cuanto llegue el DEA, encenderlo y seguir sus instrucciones de voz: descarga si la indica y reanudar compresiones inmediatamente después. No detener la RCP hasta que la persona respire o se mueva, llegue ayuda profesional, o el rescatista esté exhausto. En posible sobredosis o ahogamiento, las ventilaciones son especialmente importantes.

3. Atragantamiento: maniobra de Heimlich (compresiones abdominales)

Fuente: Guías AHA/Cruz Roja de primeros auxilios para obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño - Emergencias: SAMU

Agentes: aya, tupac

Obstrucción LEVE (la persona puede toser o hablar): animarla a seguir tosiendo con fuerza; no dar golpes ni maniobras todavía; vigilar de cerca. Obstrucción GRAVE en adulto o niño

mayor de 1 año (no puede hablar, toser ni respirar; se lleva las manos al cuello): pedir que alguien llame al SAMU 106 y actuar de inmediato con la maniobra de Heimlich: colocarse detrás de la persona, rodear su cintura con los brazos, poner un puño con el pulgar hacia adentro justo por encima del ombligo (debajo del esternon), sujetar el puño con la otra mano y realizar compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba, repitiendo hasta que expulse el objeto o pierda el conocimiento. Alternativa recomendada: alternar 5 golpes secos entre los omoplatos con 5 compresiones abdominales. En gestantes o personas con obesidad: compresiones en el centro del pecho (torácicas), no abdominales. En bebés menores de 1 año: NO hacer Heimlich; sostener al bebé boca abajo sobre el antebrazo y dar 5 golpes entre los omoplatos, luego voltear y dar 5 compresiones torácicas con dos dedos, alternando. Si la persona queda inconsciente: bajarla al suelo con cuidado e iniciar RCP, revisando la boca antes de cada ventilación.

4. Mordedura de araña casera (*Loxosceles laeta*) y suero antiloxoscelico

Fuente: MINSA / Instituto Nacional de Salud (INS) - Norma y manejo de loxoscelismo en el Perú; el INS produce el suero antiloxoscelico

Agentes: aya, tupac

La araña casera *Loxosceles laeta* ('araña violinista' o 'violonchista') vive dentro de las casas peruanas: rincones oscuros, detrás de cuadros y muebles, en ropa y zapatos guardados. Su mordedura causa loxoscelismo, una emergencia médica. Formas clínicas: CUTANEA (la más frecuente, ~85 %): dolor creciente, enrojecimiento y una placa violácea ('placa livedoide') que puede evolucionar a necrosis de la piel en 24-72 horas. CUTANEO-VISCERAL (grave, ~15 %): además, en las primeras 24-48 h aparecen orina oscura (color coca-cola), ictericia, fiebre y anemia por hemólisis; puede causar falla renal y muerte. Primeros auxilios: lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local, retirar anillos/pulseras, NO cortar, NO succionar, NO aplicar torniquetes ni emplastos, y si es posible capturar la araña (incluso aplastada) para identificación. ACUDIR DE INMEDIATO al establecimiento de salud u hospital - llamar al SAMU 106 si es grave. Tratamiento específico: SUERO ANTILOXOSCELICO producido por el Instituto Nacional de Salud (INS), más eficaz dentro de las primeras horas tras la mordedura; disponible en hospitales de referencia. Vigilar el color de la orina las primeras 48 horas. Prevención: sacudir ropa, zapatos y camas antes de usarlos, limpiar detrás de muebles y cuadros.

5. Plan de evacuación por huaico o deslizamiento (INDECI)

Fuente: INDECI - recomendaciones oficiales ante huaicos y deslizamientos (Plan Familiar de Emergencia) - Emergencias: IND

Agentes: tupac, aya, pacha

ANTES (preparación): identificar con la familia las zonas seguras y rutas de evacuación señalizadas por el municipio/INDECI (partes altas, alejadas del cauce de quebradas y ríos). Preparar la MOCHILA DE EMERGENCIA: agua (2 L por persona), alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín, medicamentos personales, copia de documentos (DNI), abrigo, silbato y efectivo. Acordar un punto de reunión familiar. En temporada de lluvias (diciembre-abril, especialmente en quebradas como las de Chosica), estar atentos a las alertas de SENAMHI e INDECI. DURANTE: al escuchar la alarma o un ruido creciente desde la quebrada (piedras, agua), EVACUAR DE INMEDIATO hacia las zonas altas por las rutas establecidas, sin regresar por pertenencias. Nunca cruzar el cauce ni intentar atravesar el flujo de lodo a pie o en vehículo. Alejarse de postes y cables eléctricos. DESPUES: permanecer en la zona segura hasta el anuncio oficial; no ingresar a viviendas afectadas hasta su evaluación; hervir o desinfectar el agua antes de consumirla; reportar personas heridas o atrapadas. Numeros de emergencia: INDECI/COEN 115, Bomberos 116, SAMU 106, Policía

6. Ley General de Salud N° 26842: emergencia obligatoria y consentimiento informado

Fuente: Ley N° 26842, Ley General de Salud (1997) - Arts. 3 (modif. por Ley N° 27604), 4, 15 y 25

Agentes: yaku, inti, aya

ATENCION DE EMERGENCIA OBLIGATORIA (Art. 3, modificado por Ley N° 27604): toda persona tiene derecho a recibir atención médico-quirúrgica de emergencia en cualquier establecimiento de salud, público o privado, cuando este en riesgo grave su vida o su salud. Ningún establecimiento puede negar la atención de emergencia ni condicionarla a pago previo, garantía o trámite administrativo mientras subsista el estado grave de riesgo.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Art. 4): ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo, o el de la persona llamada legalmente a darlo. Se exceptúan las intervenciones de emergencia. DERECHOS DEL USUARIO (Art. 15): toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho, entre otros, al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad; a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica; a no ser objeto de experimentación sin su consentimiento; a que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre su diagnóstico, tratamiento, riesgos y alternativas; y a negarse a recibir o continuar un tratamiento (con las excepciones de ley).

CONFIDENCIALIDAD (Art. 25): la información sobre el acto médico es reservada; el profesional y el establecimiento están obligados a guardar esa reserva, con excepciones tasadas por ley (orden judicial, vigilancia epidemiológica, etc.).

7. Boletín ENFEN: El Niño / La Niña costeros y anomalías del mar peruano

Fuente: Comisión Multisectorial ENFEN (IMARPE, SENAMHI, IGP, DHN, ANA, INDECI, CENEPRED) - Boletines y comunicados

Agentes: yaku, pacha, tupac

La Comisión Multisectorial ENFEN (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) es el ente oficial peruano que monitorea y comunica el estado de El Niño y La Niña. Emite comunicados y boletines periódicos con niveles de alerta: 'No activo', 'Vigilancia de El Niño/La Niña costera' y 'Alerta de El Niño/La Niña costera'. EL NIÑO COSTERO: calentamiento anómalo del mar frente a la costa de Perú y Ecuador (región Niño 1+2). Se clasifica con el Índice Costero El Niño (ICEN), basado en la anomalía de la temperatura superficial del mar. Efectos típicos: lluvias intensas e inundaciones en la costa norte, huacos en quebradas (como las de Lima este), afectación de la pesca (la anchoveta migra o profundiza al reducirse el afloramiento de aguas frías). LA NIÑA COSTERA: enfriamiento anómalo del mar; suele asociarse a déficit de lluvias en la costa y a veces mayores lluvias en la sierra sur. El mar peruano normalmente es frío por la Corriente de Humboldt y el afloramiento costero, lo que sustenta una de las pesquerías más productivas del mundo; por eso las anomalías térmicas (medidas en °C respecto al promedio climatológico) son el indicador clave que vigila ENFEN. Ante alertas ENFEN, INDECI y CENEPRED activan planes de preparación ante lluvias y huacos.

8. Monitoreo sísmico del IGP: silencio sísmico de la costa central y preparación

Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) - Centro Sismológico Nacional; INDECI (115) - recomendaciones oficiales de preparación

Agentes: yaku, pacha, tupac

El Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico: la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana, generando la mayor parte de los sismos del país. El IGP (Centro Sismológico Nacional) monitorea la actividad sísmica 24/7 y publica los parámetros oficiales de cada sismo (magnitud, epicentro, profundidad). SILENCIO SÍSMICO DE LA COSTA CENTRAL: frente a Lima y Callao existe una zona de acoplamiento sísmico que no libera energía significativa

desde el gran terremoto de 1746. El IGP advierte que esa energía acumulada podría generar un sismo de magnitud en torno a 8.8, acompañado de tsunami en el litoral. No es posible predecir cuando ocurrirá: la preparación es la única defensa. PREPARACIÓN (INDECI): identificar zonas seguras internas y externas; asegurar muebles altos; tener MOCHILA DE EMERGENCIA (agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, documentos, silbato, abrigo) y caja de reserva; participar en los simulacros nacionales. DURANTE el sismo: mantener la calma, alejarse de ventanas, ubicarse en zonas seguras; no usar ascensores. Si está cerca del mar y el sismo fue fuerte o prolongado: evacuar de inmediato hacia zonas altas por riesgo de tsunami sin esperar alerta oficial. Emergencias: INDECI/COEN 115; información sísmica oficial: IGP (www.gob.pe/igp).

9. Kit de emergencia familiar y evacuación (INDECI)

Fuente: INDECI - Preparación ante desastres / Guía familiar de emergencia

Agentes: tupac, pacha, yaku

Kit mínimo recomendado: agua (3 L/persona/día, ideal 3 días), alimentos no perecederos, linterna + pilas, radio a pilas, botiquín, medicamentos personales, silbato, cargador/powerbank, documentos en bolsa impermeable, efectivo, tapa bocas, ropa abrigadora. Antes: identificar zona segura, rutas de evacuación y punto de reunión familiar. Durante sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse. Durante huaico: subir a zona alta, no cruzar corrientes. Después: verificar fugas de gas/agua, no usar ascensores, seguir canales oficiales INDECI/COEN.

10. Como leer precipitación y alerta hidrológica

Fuente: SENAMHI - Avisos meteorológicos / umbrales orientativos de lluvia

Agentes: pacha, tupac, yaku

La precipitación se mide en milímetros (mm): 1 mm ≈ 1 L/m². Lluvia ligera <2.5 mm/h; moderada 2.5-10 mm/h; intensa >10 mm/h. En quebradas (p. ej. valle del Rimac / Chosica) lluvias concentradas en cabecera elevan riesgo de huaico aunque en la ciudad 'apenas llueva'. Al interpretar un mapa: color frío/teal = acumulación de agua; zonas cálidas/naranja = estrés térmico o mayor energía del sistema. Combinar con humedad del suelo y avisos hidrológicos oficiales. Acción ciudadana: despejar desagües, evitar cauces, seguir avisos SENAMHI/COEN y rutas de evacuación.

11. Sismos: antes, durante y después (familia)

Fuente: Resumen MARU basado en recomendaciones INDECI / IGP de preparación sísmica

Agentes: tupac, pacha, yaku

Antes: identificar zonas seguras, fijar estanterías, tener kit y punto de reunión, conocer rutas. Durante: agacharse, cubrirse y sujetarse; lejos de ventanas; no usar ascensores. Después: verificar fugas de gas/agua/electricidad; no encender fuego si hay olor a gas; seguir canales oficiales INDECI/COEN 115 e IGP. Teléfonos útiles: Bomberos 116, SAMU 106, Policía 105. Resumen orientativo; priorizar autoridades locales en alerta real.

12. Primeros auxilios básicos (hemorragia, quemadura, desmayo)

Fuente: Resumen MARU basado en principios de primeros auxilios AHA/Cruz Roja adoptados en capacitación ciudadana

Agentes: tupac, aya

Hemorragia externa: presión directa con gasa limpia; elevar si es posible; no retirar apósitos empapados - añadir encima. Quemaduras: agua tibia corriente; no remedios caseros grasos; cubrir con apósitos limpios. Desmayo: tumbar, elevar piernas si no hay trauma;

valorar vía aérea y respiración. Activar SAMU 106 ante compromiso vital. Este resumen no reemplaza curso formal de primeros auxilios.

13. Huaicos en quebradas: alerta temprana ciudadana

Fuente: Resumen MARU basado en INDECI / COEN y experiencia de cuencas (p. ej. Rimac)

Agentes: tupac, pacha

Lluvias intensas en cabecera + suelos saturados elevan riesgo de huaico aunque en el valle 'casi no llueva'. Señales: turbidez súbita, ruido de arrastre, avisos SENAMHI/COEN. Acción: subir a zona segura predefinida; no cruzar cauces; no regresar por pertenencias. Mantener kit, documentos y punto de reunión familiar. Numeros: INDECI/COEN 115, Bomberos 116.

14. Avisos SENAMHI: lectura orientativa de niveles

Fuente: Resumen MARU basado en lógica de avisos meteorológicos SENAMHI (consultar boletín oficial vigente)

Agentes: pacha, tupac

Los avisos meteorológicos suelen escalar por impacto potencial (amarillo -> naranja -> rojo).

MARU debe remitir al boletín/aviso oficial del día y no inventar umbrales de color si no están publicados. Combinar precipitación, viento, temperatura extrema y avisos hidrológicos.

En costa central y sierra, el mismo mm de lluvia no implica el mismo riesgo: importa la cuenca y la humedad previa del suelo.